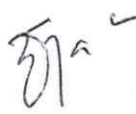


INSTRUKSI KERJA

PENANGANAN REAKSI DONOR AKIBAT PENGAMBILAN DARAH DONOR

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-013
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	21 NOVEMBER 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	21 NOVEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10.11.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 11.11.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomedik Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15.11.2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomedik Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17.11.2022

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PENANGANAN REAKSI DONOR AKIBAT PENGAMBILAN DARAH DONOR		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L3-013 Versi : 001 Tgl. berlaku : 21-11-2022 Tgl. kaji ulang : 21-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

1. Tujuan

Instruksi kerja ini menjelaskan tentang proses penanganan reaksi yang tidak diinginkan pada pengambilan darah donor

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas teknis pengambilan darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Donor hendaklah dipantau baik Selama prosedur pengambilan darah berlangsung, maupun pasca donasi (15 menit post donor).
- 3.2 Petugas harus terlatih untuk memberikan bantuan yang tepat bila terjadi reaksi samping yang tidak diinginkan.
- 3.3 Pemantauan pendonor dilakukan sampai kondisinya cukup baik untuk pergi tanpa pengawasan.
- 3.4 Perawatan segera diberikan kepada pendonor bila ada reaksi samping.
- 3.5 Informasi mengenai reaksi samping dan proses melacaknya tersedia untuk mengevaluasi jumlah, jenis dan tingkat keparahan reaksi.
- 3.6 Reaksi yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan untuk meningkatkan keamanan pendonor.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah
- 4.2 PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Reaksi Samping adalah reaksi yang timbul sesaat dan sesudah dilakukan pengambilan darah donor

5.2 Singkatan

- 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
- 5.2.2 PerKa : Peraturan Kepala
- 5.2.3 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PENANGANAN REAKSI DONOR AKIBAT PENGAMBILAN DARAH DONOR		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L3-013 Versi : 001 Tgl. berlaku : 21-11-2022 Tgl. kaji ulang : 21-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

Kursi Donor
 Bantal Donor
 Selimut Donor

6.2 Bahan Habis Pakai

Cologne
 Emergency kit
 Es
 Kassa steril
 NaCl 0,9%
 Perban tekan
 Anti hematoma
 Plastik non infeksius

7. Instruksi Kerja

7.1 Penanganan Reaksi Donor Akibat Pengambilan Darah

Amati tanda - tanda reaksi pengambilan darah, jika donor :

7.1.1 Pingsan

- Baringkan donor tanpa alas dengan posisi kedua kaki dinaikkan dengan posisi kedua kaki lebih tinggi dari kepala.
- Longgarkan pakaian dan sabuk.
- Yakinkan bahwa donor mendapatkan udara yang cukup.
- Monitor tekanan darah donor, pulsasi nadi dan frekuensi pernafasan periodik hingga donor pulih.
- Donor dengan hipotensi mungkin memerlukan infus NaCl 0,9% atas instruksi dan pengawasan dokter.

7.1.2 Mual dan Muntah

- Buat donor nyaman mungkin.
- Instruksikan donor yang mual untuk menarik nafas dalam dan pelan.
- Balikkan kepala donor ke samping.
- Sediakan tisu bersih jika donor muntah.
- Yakinkan kepala donor berbalik ke samping agar tidak terjadi aspirasi.
- Berikan air untuk membasahi mulut donor setelah donor berhenti muntah.

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN REAKSI DONOR
AKIBAT PENGAMBILAN DARAH
DONOR**

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 5
Nomor : UDDP-PDD-L3-013
Versi : 001
Tgl. berlaku : 21-11-2022
Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

7.1.3 Hematom selama atau sesudah donasi

- a. Cabut jarum dari lengan donor.
- b. Lepaskan tensimeter dari lengan donor.
- c. Letakan 3-4 kassa steril di atas luka tusukan.
- d. Tekan keras dengan jari hingga 7-10 menit.
- e. Letakan es di area yang hematom selama 5 menit, jika disetujui oleh donor.
- f. Jika arteri yang tertusuk :
 - segera cabut jarum
 - tekan keras selama 10 menit
 - Letakkan perban tekan
 - Cek nadi radius
- g. Jika nadi tidak teraba atau lemah segera lapor dokter

7.1.4 Kejang

- a. Letakkan benda yang lunak/ kassa steril gulung supaya lidah tidak tergigit.
- b. Donor dimiringkan supaya tidak terjadi aspirasi.
- c. Jauhkan dari tempat yang membahayakan donor.
- d. Berikan oksigen 2-3 L/menit.
- e. Berikan anti konvulsan yang bekerja cepat, misalnya injeksi anti konvulsan dengan dosis 0,5 sampai 1 ampul (5mg) di encerkan karena melalui vena (IV).
- f. Segera Lapor

7.1.5 Kesulitan Jantung Serius

- a. Segera hubungi bantuan medis atau bagian gawat darurat.
- b. Berikan CPR hingga bantuan datang jika donor mengalami "jantung berhenti".

7.2 Kejadian yang tidak diinginkan pada donor:

7.2.1 Pre syok (mual, muntah, pusing), syok/ pingsan

7.2.2 Gatal/ alergi terhadap: alkohol, betadin, plester, cairan antikoagulan (walau jarang)

7.2.3 Kesemutan

7.2.4 Tertusuk vena, arteri dan syaraf, hematoma, bengkak dan nyeri

7.2.5 Kejang

7.2.6 Keluhan jantung serius.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PENANGANAN REAKSI DONOR AKIBAT PENGAMBILAN DARAH DONOR		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-PDD-L3-013 Versi : 001 Tgl. berlaku : 21-11-2022 Tgl. kaji ulang : 21-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	21 – 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

